Marco 2 mínimo — modelo e loop implementados

Suposição de design, não verificado. O usuário dispensou a pesquisa da wiki e autorizou esta fatia. Fontes/limites. Este resumo substitui a proposta anterior; a versão PDF acompanha este modelo atualizado.

Dados

Registro	Estado e contrato
Catálogo humanoide	12 partes conectadas; tecidos de membros, tronco e cabeça. Compartilhado e imutável. Partes intactas são derivadas do catálogo.
`Body`	Pessoa, sangue, dor, consciência, relógio clínico, arma e armadura. Separado da pessoa; não contém cópia da árvore anatômica.
`Part`	Apenas partes alteradas: presença, função nervosa, osso e último evento. Ausência de conexão inutiliza descendentes; a outra mão pode continuar funcional.
`Wound`	Dono, parte, agressor, arma, duelo, fonte, sangramento, perda acumulada, fratura, lesão nervosa, amputação, cuidado, prazo e sequela.
`PhysicalGoal`	Objetivo marcial, requisitos de preensão, viabilidade, adaptação/abandono e períodos de prática.
`Duel`	Participantes, decisão de iniciar/aceitar, instante inicial, feridas, término e desfecho.
`Kill`	Chave única por vítima; morte factual, causa principal, ferida, arma, parte e responsável. Não confunde morte posterior externa com morte deste duelo.
Pessoa/lugar	Conhecimento de lesão aguda/permanente, habilidade médica; material finito de cuidado no lugar. Personalidade e valores vêm do 1d.

O log compacto conserva eventos, deltas, causas e decisões. As substituições temporárias de entidades são convertidas em patches no armazenamento; sangramento não copia pessoa ou corpo anatômico completo. Replay e retomada mensal são determinísticos. Não foram adicionados índices de agentes ou caches de decisão.

Loop

1. Inicializar corpos e materiais. Avaliar intenção/aceitação do duelo e elegibilidade do equipamento; sem arma não há golpe nesta fatia.

2. Até seis trocas: verificar arma, conexão, preensão e consciência; comparar ataque/defesa; escolher parte presente; consumir orçamento de contato na armadura e nos tecidos. Uma lâmina cortante e três opções de armadura (nenhuma, couro, malha).

3. Criar ferida e alterar somente os registros afetados. Soltar arma incompatível. Registrar percepção própria ou testemunhada; lesão vital que elimina consciência não produz percepção própria posterior.

4. Percepção → emoção do 1d → estresse → transformação (quando aplicável) → reavaliação explícita de objetivo. Bloquear informação impede a reação à lesão desconhecida. Notícias posteriores exigem emissor informado e presença.

5. Saltar aos limites clínicos: cuidado, coagulação ou morte. Cuidado exige presença, consentimento, mãos funcionais, habilidade, ferramentas e bandagens; pode falhar. Morte única interrompe ações; a ferida que mais contribuiu à hemorragia fundamenta a atribuição principal.

6. Por mês, agregar reabilitação em um evento por período; resolver prazos de recuperação (dois/seis meses), registrar sequela e nova percepção. Colapsar períodos repetidos antes de calcular profundidade causal no relatório.

A fixture fixa contato de 100 U no antebraço, couro, 6 mL/min e cuidado aos 5/15 minutos. Sangue 5000→4970→4958 mL; preensão 1→0,4→0,7 após cuidado e reabilitação. Sem cuidado há morte no minuto 335. São unidades e regras de jogo, não medicina real nem reprodução confirmada de Dwarf Fortress.

Limites e próxima etapa

Sem infecção, regeneração sanguínea, desgaste de armadura, múltiplos modos de ataque, locomoção detalhada ou demografia. Sangue é uma reserva fisiológica; não substitui lesões e funções por HP global. A regra de lesão nervosa sem coagulação espontânea torna este protótipo letal e deve ser avaliada separadamente, sem quotas de desfecho. A proteção abstrata anterior ainda precede os duelos no cenário amplo.

A avaliação usa 100 seeds livres e 100 reservadas, sem regeneração seletiva; três exemplos são escolhidos depois de gerar o lote completo. Testes e benchmarks constam do relatório. Família, nascimento, envelhecimento e morte natural continuam propostos para o Marco 2b, antes das civilizações do 3. **Parar ao final desta fatia.**